

11 - 03- Les Aménorrhées - Pr. Asmouki

Vous avez vu la dignition de la figure améliorée, c'est quoi ? Vous avez vu le schéma, n'oubliez pas le cap à caractéristiques principales des règles chez la femme. Donc la durée, la quantité, la fréquence et la régularité. C'est la normalité avant de parler de ce moment éternel.

C'est un moment où on a dit que la définition de la même tableau, dans ce tableau-là qui parle de tout ça, améliorée par définition, c'est l'absence de règle pendant trois mois. C'est trois mois. Là, on pratique, une fois qu'il y a un retard de règle de 20 jours, on dit qu'elle est améliorée.

C'est un terme qui n'est pas, mais c'est très courant. On n'a pas eu ces règles et on a amélioré. Alors que la définition, c'est trois mois.

Pourquoi ça ? Parce que ce n'est pas l'appel de faire des investigations. Il faut attendre trois mois avant de commencer à faire des investigations. Bien sûr qu'il dit améliorée, toujours le problème de la grossesse.

D'autres choses également. Ici, j'ai essayé de chaque cours de vous donner deux choses. Dans le système immunitaire normal, on craint le cancer et on craint la grossesse.

Dans l'améliorée, on craint également la grossesse avec ses complications qu'on doit parfois prendre en charge de façon urgente. Mais on craint également l'aménopause, l'aménopause précoce. Ça, c'est les deux choses qu'on peut, il faut toujours les avoir.

Quand on a une améliorée, la grossesse, l'aménopause. Là, c'est des petits trucs, des petites astuces. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer ? Déjà, primaire et secondaire, c'est totalement deux situations totalement différentes.

Ce ne sont pas les mêmes idéologies. Il y a des idéologies qui sont communes, mais ce n'est pas la même façon. Une femme qui n'a jamais eu de règles, ce n'est pas la même chose qu'une femme qui a eu des règles et qui est maintenant en améliorée.

Donc, c'est totalement différent. C'est pour cela qu'on va essayer de les partager. Toujours démarches diagnostiques, démarches étiologiques, principes de traitement.

Alors, quand vous n'avez pas beaucoup l'habitude des questions de synthèse, quand on vous pose un symptôme, surdité, céphalo, saignement, ématurie, toujours c'est la même démarche. On introduit l'introduction, c'est à la diminution, la gravité, l'intérêt. Il y a une démarche diagnostique, il y a une démarche thérapeutique.

Toujours, démarches diagnostiques, démarches thérapeutiques. C'est des symptômes qu'on ne va pas sortir d'introduction, démarches diagnostiques, démarches étiologiques, démarches thérapeutiques. Démarches diagnostiques, démarches étiologiques, démarches thérapeutiques.

Toujours, vous y créez-vous dans ce sens-là. J'attends l'ématurie, je définis l'ématurie, je parle des diagnoses différentielles, je parle de la cause principale, du risque, de l'intérêt de la question, et je fais la démarche diagnostique. La démarche diagnostique, qu'est-ce que je vais demander à l'interrogatoire ? Qu'est-ce que je vais faire dans l'examen clinique ? Quels sont les principaux examens paracliniques que je vais demander ? C'est-à-dire les démarches diagnostiques.

La démarche étiologique, chaque étiologie, je commence en général, soit par les plus graves ou les plus fréquentes, chaque étiologie, je vais voir qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'interrogatoire de diagnostic positif, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'examen physique, à l'examen clinique, et quels sont les éléments paracliniques ? Pour chaque étiologie, je vais lui donner ses principes thérapeutiques. Quand je vous donne les maturités, je ne vous dis pas de traiter le cancer de la viscille. Vous ne dites pas de traiter le cancer de la viscille, le traitement c'est consultation pluridisciplinaire et traitement du cancer de la viscille.

On énonce les principes, la chirurgie, l'immunothérapie, la radiothérapie, mais restez général lorsqu'on vous donne un symptôme. Ce qui est important, c'est la démarche diagnostique et les étiologies qui vont, à travers la démarche diagnostique que vous avez faite, rapporter les signes positifs, les principaux signes positifs. C'est entre parenthèses comment rédiger une question de synthèse devant un symptôme, quand vous avez un symptôme.

Un symptôme, ce n'est pas une pathologie. La pathologie, non, c'est autre chose. Le cancer de la viscille, quand je vous dis cancer de la viscille, c'est autre chose.

C'est l'introduction, l'épidémiologie, les facteurs de risque, la physiopathie, l'anatomie, le diagnostic, le type de description, le diagnostic du véricier, les formes cliniques, le traitement, ça c'est autre chose. Faites la différence, vous lisez une question de symptômes, ce n'est pas les mêmes symptômes que vous avez dans une question de pathologie. Les pathologies ont un plan, les symptômes ont un plan.

C'est parfait au hasard, c'est le plus logique. Quand je parle d'un symptôme, je suis obligé de traiter en détail toutes les étiologies. Je donne les principes thérapeutiques.

Par contre, si on me donne cancer de la viscille, je dois avoir le traitement en détail. Ça c'est juste une petite parenthèse. Quand on est au centre d'un symptôme, on fait des démarches diagnostiques, des démarches étiologiques et des principes thérapeutiques.

Lorsque les physiopathes améliorent l'absence de règles, pour avoir des règles, le fameux HHPO, l'axe hypothalamo-hépo-viso-ovarien, auxquels on ajoute l'utérus, l'axe hypothalamo-hépo-viso-ovarien avec l'utérus, il va y avoir une anomalie au niveau de cet axe-là. Il y en a une quelque part qu'il va falloir chercher. Soit l'hypothalamus, soit l'hépovis, soit les ovaires, soit au niveau de l'utérus.

Parce que s'il y a du sang, il doit être évacué. S'il n'y a pas d'utérus, on ne va pas avoir du sang.

S'il n'y a pas d'utérus, on n'a pas d'endomètre.

S'il n'y a pas d'endomètre, on ne va pas. Donc il y a des femmes qui, malheureusement, peuvent naître sans. Et ça s'appelle le syndrome de Rokitansky.

On va le voir. Anginésie millérienne totale de l'utérus. Ce n'est pas totale, c'est incomplète, parce que totale n'est pas compatible avec la vie.

Les anginésies millériennes totales, c'est l'appareil génital et l'appareil urinant, donc ils ne sont pas compatibles avec la vie. C'est les anginésies incomplètes qu'on peut trouver sous ce syndrome. Donc, pour ça, on ajoute, ça je l'ai oublié, c'est les surrénales.

Les surrénales peuvent être responsables d'améliorer dans certaines situations. On va le voir. Les surrénales, ça s'accrète quoi ? Des androgènes.

Ça s'accrète des androgènes, ça s'accrète du cortisone. Ce sont des substances très importantes pour le cycle, pour la vie, pour le métabolisme. Si on n'a pas de cortisone, on a un mauvais métabolisme.

C'est une hormone qui permet beaucoup de métabolisme. Si on a des androgènes, les androgènes ont à l'effet antagoniste des oestrogènes et de la progestérone. Surtout des oestrogènes.

Donc, on risque d'avoir des améliorations. C'est pour ça que les surrénales, qui ont une grande endocrine par excellence, vont également participer à ces taxes et être totalement épuisées aux barrières avec l'utérus. Ça, c'est pour une odeur.

Pour l'évacuation, il y a l'utérus et il y a le col et le vagin. Donc, on peut avoir une amélioration d'une partie de ces différentes étapes. Commandement hormonal, production des règles, évacuation.

Alors, on va commencer par les améliorations primaires. Les objectifs, c'est de connaître les idéologies, connaître les diagnostics, les principes thérapeutiques, l'introduction. L'amélioration, c'est l'absence des règles pendant trois mois.

Nous, on est en train de parler des améliorations primaires. L'amélioration, c'est l'absence d'écoulement de stress sur une femme au nage d'avoir ses règles. Alors, c'est un génétique fixé.

Arbitrairement, à cinq ans. Quinze ans, on ne se dit peut-être qu'elle a un simple retard de règles, un simple retard pubertaire. Au-delà de cinq ans, on commence à s'inquiéter.

Quatorze ans, quinze ans, il ne faut pas s'inquiéter. C'est vrai, ses copines de deux ans, de treize ans, elles ont des règles. Elles n'ont pas la règle.

Elles ne vont pas commencer à faire des investigations. Il faut attendre les 16 ans. Ça, c'est la

différence.

Avant 16 ans, on ne fait pas de bilan. Il s'agit d'un simple retard pubertaire. Alors, c'est une situation assez fréquente des améliorations primaires.

Des causes très, très multiples, on va le voir. On va essayer de les résumer. Bilan correct, c'est l'affectivité des traitements mal adaptés.

Il faut faire un bilan correct. Alors, devant les améliorations primaires, tous les éléments qu'on peut demander, ça dépend des étiologies auxquelles on pense. Il y a la tuberculose, je vais vous demander la tuberculose.

La tuberculose prépubertaire, la tuberculose avant la puberté, surtout lorsqu'il touche l'utérus, il peut rendre cet utérus non fonctionnel. Donc, je vais demander la tuberculose. S'il a fait une chirurgie, il est allé à l'hôpital, durant l'enfance, je vais demander s'il a une chirurgie.

S'il prend un traitement, je dois demander s'il prend un traitement, parce que ça peut entraîner tout ça. S'il a une maladie chronique, je dois demander. Donc, ça, c'est l'interrogatoire.

L'âge de la puberté, chez la femme, il y a des éléments indirects qui permettent de dire la génétique. La puberté, c'est pour voir la génétique. Il y a des familles qui ont des filles pubères fréquemment.

Donc, l'âge jusqu'à la puberté des mères et des sœurs, des pathologies médicales qui peuvent expliquer ce problème dans les oreilles, notamment une maladie chronique, une traumatisation crânienne, une inondation, une inondation. L'hypophyse de l'hypothalamus, c'est à côté de l'hypophyse. Si on a l'hypophyse à côté de l'hypophyse, ça va entraîner sa fonction.

Alors, quand on vous demande des antécédents, je vous demande est-ce qu'on fait un traitement ? Est-ce que vous avez une maladie chronique ? La femme me dit non, je n'ai pas de maladie chronique. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ? Toujours demandez, est-ce que la femme a été hospitalisée ? Si vous dites qu'il n'y a pas de maladie chronique, la femme connaît bien sa maladie. Parfois, elle ne connaît pas bien sa maladie.

Quand j'avais l'âge de 5 ans, j'ai été hospitalisé pour le meningite. Elle n'a pas d'antécédent, mais quand vous lui demandez est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ? Donc, il faut poser, est-ce qu'il y a un séjour à l'hôpital ? C'est la question des astuces, il faut toujours demander cette question-là. Comme ça, vous ne ratez aucun antécédent importe.

Demandez, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ? Alors, les chirurgies, les pédométies, le cortico, tout ça, si il y en a, on va les avoir. Les développements pulvataires, le sein, la pénosité, les organes génitaux externes, on va demander également ça. On va aller chercher un examen clinique.

Le sein d'accompagnement, douleurs cycliques, parce qu'il y a des chirurgies qui contraignent des douleurs cycliques. Si on a un obstacle, la femme va avoir des règles, au moment des règles, elle va avoir mal. Si elle n'a plus de règles, elle ne va plus avoir mal.

Le cycle prochain, au moment des règles, elle va avoir mal, même s'il n'y a pas de saignement. Donc, ce sont des douleurs cycliques. On va demander, très important, améliorer les douleurs cycliques, on va demander.

Ça fait partie de la démarche diagnostique. Troubles visuels, alors. Troubles visuels, c'est un problème cérébral, le tumeur cérébral, le tumeur prévisé.

Par contre, les troubles de l'infarction, il y a un syndrome. Il y a un syndrome anosmi avec améliorer, c'est le syndrome de Karlmann-Morcier. C'est une anomalie congénitale de migration de l'hépophyse et de l'hépotalamus.

Ça entraîne une amélioration. Un problème de faute de commande et de régulation. Donc, l'anosmi, il faut demander s'il y a un anosmi.

Surtout lorsqu'on n'a pas un contexte très évocateur. Parfois, le contexte, il est très évocateur. Une fille de 15 ans qui vient 4 mois, 5 mois auparavant, durant chaque mois, pendant 5 jours, 6 jours, il avait très mal, mais il n'a pas de sévèrement.

Deuxième mois, la même chose. Troisième ou quatrième mois, il vient consulter. Il vient consulter.

Premier diagnostic, douleur cyclique, 15 ans, il devait avoir ses règles, il n'a pas eu ses règles, ce qui n'est pas un obstacle. J'ai fait l'examen gynécologique, j'écarte la vue, je vois qu'il y a une masse. C'est une imperforation de l'image.

Je ne vais pas demander autre chose, scanner, IRM, bilan hormonal. J'ai le diagnostic devant moi. C'est une imperforation de lui-même.

Il suffit de faire une incision de cette imperforation-là, le problème est réglé. Donc, le bilan, on lui demande une fonction. Parfois, le diagnostic n'est pas évident.

Ce n'est pas l'appel d'aller tout le monde. Quand le diagnostic n'est pas évident, c'est même là qu'on va demander plus d'examens. D'autres choses que vous devez également connaître, les sports de haut niveau, les efforts excessifs, les sports très intenses.

Par exemple, les athlètes, ils ont souvent des améliorés. Ils ont souvent des améliorés. Les athlètes de haut niveau, du fait de l'exercice, ça agit au niveau du cerveau, ça dérègle.

Ça dérègle l'axe hypothalamment propice. Il y a une pathologie qui est grave, on peut assimiler à cet effort physique intense, c'est l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, la fille ne mange pas

parce qu'elle a un régime très à l'aide.

Quand on ne mange pas, on ne va pas avoir de règles. Quand on est trop maigre, ça donne des signaux au cerveau qui lui disent stop, ne pas engueuler. Donc, on doit avoir des règles.

Pour tout ça, c'est lié. Donc, le sport intense, c'est partiellement à cause de troubles du cycle et même d'améliorés. Ils ont aussi des spasmes améliorés, voire des améliorés.

Ça peut entraîner des problèmes psychologiques comme l'anorexie mentale. Vous connaissez l'anorexie mentale ? L'anorexie mentale, c'est des sujets, vous l'avez vu dans votre vie, vous n'allez jamais l'oublier. C'est des femmes, en général, les stars de la mode, elles veulent rester maigres à tout coup.

Elles ne mangent pas pendant une semaine, elles ne font que boire. Elles arrivent dans une situation où elles ont un cas sceptique. Et ces femmes-là, souvent, dans 100% des cas, elles n'ont pas de règles.

Parce que l'axe hypothalamo-hypophyseur, du fait de ce régime, elle est très perturbée. Alors, l'examen clinique, je ne sais pas comment faire disparaître le truc. Voilà, c'est très simple.

On voit la poids à la taille, est-ce qu'il y a une croissance complète ? Poids à la taille. Les signes de puberté, est-ce qu'il y a des caractères sexuels secondaires ? Les signes de puberté, le sein, la pilosité, les organes génitaux externes. Est-ce qu'il n'y a pas un faciès particulier, une dysmorphie ? On fait allusion à quoi ? Il y a beaucoup d'anomalies chromosomiques qui peuvent entraîner une dysmorphie.

Laquelle ? C'est le syndrome de Turner. Donc on voit, est-ce qu'il y a une dysmorphie particulière ? Une existence d'acné, plus ou moins sévère. Quand je parle d'acné sévère, je parle quoi ? D'hyperandrogénie.

Acné sévère, c'est penser à l'hyperandrogénie. C'est-à-dire la pilosité, c'est-à-dire la raucité de la voix, la voix roque. Tout ça, c'est des signes d'hyperandrogénie.

Une hyperandrogénie, l'hyperplasie du surrénal, va entraîner une aménorrhée. Pour connaître ça, il faut attendre l'examen psychologique capital. Toujours l'examen psychologique capital.

On va inspecter. La première chose, on va à la vue. Est-ce qu'on est normal ? Pourquoi on va à la vue ? Déjà, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille ? Lorsqu'on n'a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas de caractère sexuel.

On se pose la question, est-ce qu'elle a été toujours élevée comme fille ? Est-ce qu'elle est vraiment une fille ou non ? On va voir ça. Dans l'étiologie, on va voir le testicule qui s'est créé des androgènes mais qui n'a pas de récepteurs d'androgènes. Lorsqu'il n'y a pas de récepteurs d'androgènes, l'individu garde un aspect, soit en pubère, soit féminin.

Ce sont les oestrogènes avec les récepteurs oestrogènes qui donnent à la femme l'aspect de femme. S'il n'y a que des androgènes et pas d'oestrogènes, on peut avoir des problèmes d'ambiguïté sexuelle. On va voir ça.

L'examen gynécologique, on voit les organes externes, les clitoris, les veines, puisqu'il n'y a pas d'autre chose. L'examen au spéculum de vierge est besoin. Parfois, l'obstacle, ce n'est pas l'imme, mais derrière l'imme, il va y avoir un diaphragme.

Un diaphragme. On a la fille qui souffre tous les mois, l'imme, elle est perméable, mais on sent qu'il y a une masse derrière l'imme. On peut avoir un diaphragme vaginal qui, lorsqu'on a un obstacle au niveau du vagin, le sang se collecte au niveau du vagin, mais il n'est pas expulsé.

Parce qu'il y a un diaphragme qui bloque. Il suffit également d'ouvrir ce diaphragme pour libérer les choses. C'est plus difficile qu'en eux-mêmes.

Diaphragme vaginale, le traitement, c'est plus difficile. Souvent, il y a d'autres malformations au niveau de l'utérus. Quand on fait des touches vaginales, une touche rectale avec un doigt, un pourcentage de la patiente, on peut voir l'utérus.

On peut voir l'utérus à travers le rectum. Après, si on sait sa taille, on peut trouver l'utérus. Mais à côté, il y a une autre masse.

Masse ovarienne. On peut parler d'un autre composant. Alors là, c'est une occasion pour m'expliquer un petit peu.

Lorsqu'on a du sang qui est collecté au niveau du vagin, on parle de quoi ? De l'hématocorpose. L'hématocorpose, c'est du sang collecté au niveau du vagin. Lorsqu'on a, je vous donne l'exemple d'une imperforation de l'imme.

Il y a le dommeur cyclique, l'absence de règles. Quand on fait l'examen, touche rectale, on va trouver une masse au niveau du vagin. C'est l'hématocorpose.

Si les choses, bien sûr, s'il n'y a pas de règles, avec le temps d'un jour, trois jours, une semaine, dix jours, le sang qui était contenu dans le vagin va se résorber. Il va se résorber, le phénomène du sang qui va coaguler, du plasma, il va se résorber en fonction de la quantité du sédiment. Parfois la quantité du sédiment est tellement petite que les choses se résorbent, on n'a pas de masse.

Parfois elles se résorbent, mais par comportement, le sang dérègle le sédiment, ils vont s'ajouter au sang dérègle du mois qui va suivre, ils vont s'ajouter au sang dérègle, ça va donner une masse au niveau du vagin. C'est ce qu'on appelle l'hématocorpose. Si on ne fait rien, le sang va remplir au-dessus du vagin, l'endomètre va remplir l'utérus.

On parle d'hématome, ça ne veut pas dire que c'est la trompe, vous avez sorti. Hématométrie,

métrie c'est l'utérus, métrite c'est une endométrite, paramètre c'est à côté de l'utérus. Donc, hématométrie.

Si on ne fait rien, le sang arrive au niveau, il n'arrive pas à sortir par le bas, il va occuper la trompe. Et on parle à ce moment-là d'hématosalpinx, c'est comme la jus, la jus, on a du sang au niveau de la trompe, avant la rupture, c'est l'hématosalpinx. Si on ne fait rien, après l'hématosalpinx, le sang va passer dans le péritoine, et lorsqu'il passe dans le péritoine, quel est le risque ? Le risque, c'est l'endométriose.

Le risque, c'est des lombos de cet endomètre qui vont s'implanter au niveau du péritoine, du pelvis, et donner ce qu'on appelle la fameuse maladie d'endométriose externe, qui est très grave. Qui est très grave. Ça donne des adhérences, des infertilités, des douleurs, tout ce que vous voulez.

L'hématosalpinx, c'est grave pour les trompes. Ce qui fait ces problèmes d'obstacles, il faut les diagnostiquer rapidement et les traiter rapidement afin de ne pas bousiller tout l'appareil génital. Donc l'hématocorpose, c'est le corpore sauvageant, l'hématose et le sang.

Vous pouvez ajouter l'hématocorpose, l'hématométrie, l'hématosalpinx dans le pelvis avec l'endométriose externe. Vous pouvez rajouter tout ça. Dans l'examen clinique, on n'oublie jamais, il y a les hyperprolactinemies.

Il y a les hyperprolactinemies. L'hépophyse, il y a une glande qui sécrète la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone, c'est la substance qui permet l'allaitement.

La prolactine, il n'y a que l'allaitement. C'est la succion, le réflexe de succion qui permet de stimuler l'hépophyse et de sécréter cette prolactine. Cette prolactine agit au niveau de la glande mammaire pour la rendre hyperplasique et sécrétoire et donc donner le lait pour le bébé.

Et vous savez tous que durant l'allaitement, il n'y a pas de règles. Parce que la prolactine émette l'axe hypothalamo-hypophysaire. La prolactine, s'il est sécrétée de façon continue, il va bloquer la commande hypothalamo-hypophysaire et donc on ne va pas avoir de règles.

Donc l'hyperprolactinémie bloque la survenue des règles par inhibition centrale. C'est pour cela qu'à la fin de l'examen, on voit les seins, on essaie de pincer un petit peu les seins pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Le caractère de l'écoulement mammaire dans les hyperprolactinémies est orthogonalmonique.

Ce n'est pas un seul port qui sécrète. Les deux seins et plusieurs ports. En général, il y a 20 ports par sein.

Si on examine, il n'y a pas que le liquide qui sort d'un seul canal. S'il n'y avait qu'un seul canal qui sécrète le liquide, on va dire quoi ? C'est un problème organique. C'est un papillome, un tumor au niveau de l'ongule qui donne cette sécrétion-là.

Ça, c'est général. Quand c'est général, ça agit au niveau de tout l'ongule. Et quand ça agit au niveau de tout l'ongule, c'est que les sécrétions vont être bilatérales et multiports.

Et ce n'est pas sanglant, c'est comme du lait. C'est du clostrant, c'est comme du lait. Donc, on cherche une galactorée parce que les hyperprolactinémies, c'est à côté de l'épophyse, c'est à côté de l'hypothalamus, ça peut gérer la survenue d'ovulations et donc de règles.

Quand vous allez voir les idéologies, il y a des choses. Pourquoi on va leur demander ? Pourquoi la tuberculose ? L'âge des ménages ? Est-ce que ce n'est pas un retard pubertaire ? Simple. Toutes les choses qu'on va demander, c'est en fonction des idéologies qu'on connaît, qu'on devrait connaître.

Alors, les examens complémentaires. Je n'ai pas encore parlé de la courbe température depuis les deux séances que j'ai faites. À quoi sert la courbe température ? Vous avez déjà parlé de la courbe température ? Alors, c'était l'exemple qu'on faisait avant.

On demande à la femme, chaque matin, de prendre sa température. De préférence, température rectale. En général, la première partie du cycle, on a une température inférieure à 37 degrés.

36, 8, 36, 7, 36, 9. Avec l'augmentation, il y a un décalage. On a un plateau au-delà de 37, 37, 2, 37, 3. Donc, c'est une courbe biphasique. La courbe température, normalement, si on la prend sur un mois ou deux mois, on va trouver première partie du cycle, décalage, deuxième partie du cycle.

Première partie du cycle, décalage, deuxième partie du cycle. Pourquoi il y a une augmentation de température ? Parce que la progestérone, c'est une hormone qui est un petit peu épertermisante. La progestérone, c'est l'hormone de la grossesse, c'est l'hormone... Progestérone, c'est elle qui maintient la grossesse.

Ça entraîne un petit peu de... Il chauffe un petit peu pour que la femme reste... C'est une petite explication qui n'est pas scientifique. Progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. C'est elle qui permet de maintenir la grossesse.

Bien sûr, l'oestrogène est également dans l'eau, mais la progestérone, c'est l'hormone qui doit rester pendant la grossesse. Si on a une chute de l'oestrogène, on va avoir des problèmes dans l'implantation, dans les premières divisions de l'oeuf. Et dans le maintien de l'oeuf au niveau de l'odéus.

ce cycle... La courbe température et le biphasique, ça nous donne une idée, est-ce qu'il y a une ovulation ou non. Alors, à quoi... La courbe température, cette femme qui est aminorigique, est-ce que peut-être qu'elle fait des ovulations ? On va trouver qu'elle est plate. On va trouver une courbe qui est plate, qui n'est pas biphasique.

Mais c'est vrai, si la femme prend la température chaque jour, s'il marque ça dans un carnet, ça c'est juste pour être didactique. C'est pour savoir qu'il y a un examen qui peut nous donner une idée sur le cycle menstruel indirectement en trouvant une courbe de température qui est biphasique. Ça, on le faisait également pour savoir si la femme est enceinte ou non.

Donc, s'il n'y a pas de règles et que le plateau persiste au-delà de 14 jours, il se maintient, c'est que cette femme-là peut-être qu'elle est enceinte. Il n'y a pas de chute des hormones, donc il n'y a pas... La courbe température n'est plus biphasique, mais il s'est prolongé au-delà de 14 jours, le moment où il n'y a plus de progestérone et qu'il doit descendre. Enfin, après, si le plateau persiste, c'est peut-être qu'il y a une grossesse parce qu'il y a encore de la progestérone qui chauffe.

Donc, les examens de base améliorés, ce qu'ils ont vu, la courbe température. Moi, je pense que ça, c'est très important. C'est des jeunes, on ne sait pas est-ce qu'ils ont accompli leur croissance ou non.

On ne sait pas est-ce qu'ils ont accompli leur croissance ou non. Et on a un examen qui permet de voir est-ce que l'individu a terminé sa croissance. C'est le sésamoïde du pouce.

La radiographie de la main, on cherche le sésamoïde du pouce. Lorsqu'il est existant, c'est que cet individu-là, il a terminé sa croissance à l'âge pubert. Lorsque le sésamoïde est absent, cet individu-là n'a pas encore terminé sa croissance.

Qu'est-ce qui est grave ? Bien sûr, c'est grave. Parce que s'il n'a pas encore terminé sa croissance, on a toujours l'espoir qu'il va terminer. Mais lorsqu'il a terminé sa croissance, il n'a pas terminé.

C'est vrai que ça, c'est un petit peu plus... Mais dans les deux situations, on va trouver des choses qui sont graves. Donc la courbe température, l'âge osseux. L'âge osseux, j'insiste, amélioré primaire, on demande l'âge osseux.

Lorsqu'on n'a pas une cause évidente. Bien sûr, il faut doser l'FSH, la prolactine, LH également. L'intérêt de ce dosage-là, il est simple.

Lorsque les colonnes endothromphines, c'est-à-dire la FSH, LH, sont élevées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'axe, il fonctionne. Le cerveau, il fonctionne. L'hépatale, il épuise.

Il y a des pauses, il y a de l'épuisage qui s'est créé. Le problème, il est ailleurs. Ce n'est pas au niveau du cerveau que le problème.

Par contre, lorsque ces FSH et LH sont bas, c'est là qu'on se dit que peut-être le cerveau, c'est lui qui est la cause. Donc, lorsque nous avons une croissance élevée, l'attente, elle est périphérique, elle est ovarienne. Je n'aime pas le terme périphérique centrale parce que ça

dépend de ce qu'on appelle périphérique par parlement, périphérique par parlement.

Mais il faut retenir que FSH par l'art, ce n'est pas le cerveau, c'est un problème en dehors du cerveau. Soit au niveau de l'orbite, soit au niveau de l'utérus ou bien d'autre chose. Donc ça, lorsque les FSH sont bas, c'est que le problème, il est central.

Donc, la température, l'âge osseux, deux âges d'FSH prolactine. Lorsque la prolactine est élevée, on pense plutôt à un adénome épophysaire, c'est l'épophysie. Il y a un adénome qui va gêner l'ambulation de tous les âmes.

Donc, c'est un problème lorsqu'on n'a pas une idée évidente à demander. On n'a jamais oublié cette échographie qui va voir si la femme a un utérus ou non. Lorsqu'elle a un utérus, est-ce qu'elle n'est pas remplie de sang ? On peut voir s'il y a du sang dans le vagin avec l'échographie pelvienne.

Alors, la démarche étiologique... La démarche étiologique, la première, c'est qu'on a trois situations. Trois situations, en fonction des caractères sexuels secondaires. Voilà le terme clé pour la démarche étiologique.

Soit qu'on a des caractères sexuels secondaires qui sont normaux. Normaux, c'est-à-dire féminins. Soit qu'on a des caractères sexuels secondaires mais masculins.

Donc il y a les normaux féminins, il y a les normaux masculins, et il y a les absents. Il n'y a pas de caractère, il y a toujours l'aspect d'un enfant. Absence de caractère sexuel secondaire.

Donc on va commencer par la première situation, normaux. Lorsqu'elle a un utérus ou non, masculinisé, comme on le voit. Lorsqu'elle a les caractères sexuels secondaires normaux, on soit à un problème ou pas.

Qu'est-ce que ça veut dire caractère sexuel secondaire féminin ? C'est que les oestrogènes et la progestérone sont là. Il y a les oestrogènes et la progestérone. Donc l'envers, ce n'est pas le problème.

Ce n'est pas un problème pour elle, c'est un problème parce que la femme a des règles mais qu'elle n'arrive pas à sortir. C'est un problème anatomique. C'est un problème anatomique.

Donc c'est en fonction de ce problème anatomique-là, comment on va le différer. Si on a des douleurs cycliques, ça veut dire que le sang se forme. On a un endomètre, on a un utérus, mais on n'arrive pas à sortir à l'extérieur.

Caractère sexuel secondaire, ça veut dire qu'il y a une douleur. Il faut un endomètre. Et là, il y a une douleur, ça veut dire qu'il y a du sang qui n'arrive pas à sortir pendant que l'obstacle est à ce niveau-là.

Pendant que l'obstacle est à ce niveau-là. Alors ça peut être quoi cet obstacle ? Soit c'est un problème d'une douleur qui n'a pas été perforée, quand j'y vais pas là. Soit c'est la progestérone.

Il n'y a pas de progestérone. Il y a beaucoup d'informations sur l'état de l'endomètre. L'endomètre n'existe pas, le sang se collecte de l'extérieur à ce niveau-là.

Chaque mois, il va y avoir des douleurs qui vont avoir un endomètre métrique. Avec l'utérus fonctionnel, on va avoir un endomètre transversal. C'est-à-dire que l'endomètre va avoir une autre compréhension que l'endomètre métrique.

Ça, c'est pour vraiment simplifier. L'information utérine, c'est très, très complexe. C'est juste pour simplifier.

Pour les primaires, il y a des caractéristiques sexuelles secondaires normaux dont nous n'avons pas parlé, mais les normaux restent. Et la douleur, c'est la douleur psychique. Elle ne peut pas être exposée.

Donc, soit c'est la perne diagnostique, qui suffit d'écarter les lèvres pour voir. Soit c'est un diaphragme, un petit peu plus dans l'examen clinique. Soit c'est une apposée vaginale.

Il n'y a pas de vagin, on ne voit pas d'utérus. Une grosse masse. L'utérus, c'est 7 centimètres, maximum.

C'est l'enfant, c'est encore. C'est la jeune qui n'a jamais eu de grossesse, c'est moins, c'est 6 centimètres. On ne peut pas le voir par le rectum.

On ne peut même le voir en échographie. Donc, s'il n'y a pas de vagin, l'utérus va augmenter. Au niveau du 7 centimètre, on va trouver 12-13 centimètres.

On peut même le voir en échographie. Un grand utérus, qui contient du son, qui mesure 12 centimètres, c'est peut-être qu'il a une agénésie vaginale. L'agénésie vaginale, c'est un petit peu très difficile à traiter.

Très difficile à traiter. Quand on arrive, on va trouver une grosse masse utérine, un petit bout de vagin qui n'est pas perméable. C'est du douleur cyclique.

C'est une amélioration. Il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut créer un nouveau vagin pour les rapports sexuels et pour l'expulsion d'adultes.

Il pourrait éventuellement avoir des grossesses. Au maximum, c'est une chirurgie de l'agénésie vaginale. Ce sont des chirurgies qui sont très lourdes et pour créer le canal, il faut maintenir ce canal perméable.

C'est notre problème. On crée le canal de façon chirurgicale, mais il faut le maintenir. Si on ne le

maintient pas, après 20 jours, 3 semaines, il va se fermer.

Il va refaire son hématométrie. Ce qui fait qu'il faut l'interposer. Il y a même des gens qui sont allés trop loin.

Ils prennent une résection anastomose d'un bout d'intestin et le placent entre le col et la vue. Comme ça, c'est l'intestin qui ne va pas se fermer. C'est une chirurgie qui est très lourde.

Il faut des chirurgiens, il faut grand temps, il faut préparation pour permettre les rapports sexuels dans l'intestin, le passage de règles. Il y a des techniques qui sont décrites dans ce cas-là. Des questions ? L'exemple maintenant est primaire.

Caractère sexuel, c'est un développement mort. Douleur cyclique, les principales trois diagnostiques. Lorsqu'il n'y a pas de douleur, c'est un peu plus grave.

On n'a pas de règles, on n'a pas de douleur. Pour la femme A, on n'a pas de règles, et pour la vie de l'homme, on se dit qu'il y a un obstacle qu'on va régler. Là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur.

Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur. Et il y a des caractéristiques secondaires qui sont normaux. En parlant de l'hygiénisme de l'utérus, l'image, c'est l'image de l'imperforation de l'humain.

Lorsqu'on est cartellaire, vous voyez, on a une masse qui est bombante, qui est vraiment tendue. Elle retient les règles. C'est un diagnostic qui est très facile.

Le traitement est très facile. Il suffit de faire une incision, on mixe, puis on expulse ces règles pour le problème de la régression. C'est une information qui est très mignonne.

Ce n'est pas comme la placée du vagin. Ce n'est pas comme la chance du vagin. Les diaphragmes, c'est assez intermédiaire.

Il y a certains diaphragmes qui sont simples. Pourquoi on a deux vagins ? On a un vagin en bord et un vagin avec un diaphragme. Il y a beaucoup de complexité dans les mêmes informations.

Alors, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de douleur cyclique, ça peut être un syndrome de replitonski. On retenait le replitonski. Il n'y a pas d'utérus.

Quand il n'y a pas d'utérus, les envers sont normaux mais l'utérus, il n'y a pas de sécrétion. Il n'y a pas de sécrétion de l'endomètre. Il n'y a pas d'endomètre qui disparaît.

On a un cycle hypothalamo-hypovisant on ne voit rien, mais on n'a pas d'utérus pour effectuer l'hypertrophie de l'endomètre et son excrétion. Autre diagnostic, il y a un utérus mais qui est complètement endomagé. L'endomètre est complètement endomagé.

C'est la tuberculose prépubertaire. La tuberculose au niveau génital avant la puberté, ça détruit. C'est comme l'hystéroscopie où tu as risqué tout l'endomètre.

La tuberculose génitale au niveau de l'endomètre avant la puberté, tuberculose prépubertaire. Ça ferme. Ça ferme tout.

Donc si ça ferme tout, il y a des hormones mais il n'arrive pas à agir, il n'y a pas d'endomètre. Il y a également un diagnostic, c'est le syndrome de résistance aux androgènes, c'est le testicule féminisant. C'est le testicule féminisant.

C'est du 46XY. Sauf que ce 46XY qui a des testicules qui s'écrivent des androgènes, ces androgènes n'arrivent pas à agir au niveau des récepteurs pour orienter les caractères sexuels secondaires vers le sexe masculin. Ici il reste féminin.

Donc il reste féminin, c'est le testicule féminisant. Il a des testicules, il a des androgènes, mais il a un problème au niveau des récepteurs. Donc ce n'est pas seulement le fait d'avoir l'hormone que c'est bien.

Il faut avoir et l'hormone et son récepteur. S'il n'y a pas de récepteur, il y a des pathologies héréditaires où il n'y a pas de récepteur, donc l'hormone n'arrive pas à faire son job. Donc c'est le testicule féminisant.

J'ai une petite iconographie. C'est quoi le syndrome du testicule féminisant ? C'est le 46XY avec une morphologie féminine. Ils ont des seins, ils ont des objecteurs extérieurs.

Avec eux, il y a des patients qui sont portés des conditions de poussière, qui sont durés jusqu'à la mort. C'est ça le syndrome du testicule féminisant. du testicule féminisant.

Lorsqu'on parle des symptômes féminins, on parle des symptômes c'est-à-dire la sécurité sexuelle féminine, biologiquement, la testostérone, la testostérone majeure, et l'hormonalité, c'est-à-dire le risque de la sécrétion de l'ostérogène qui dépasse. Je vous ai dit que l'ostérogène, c'est pas seulement la testostérone qui est prédominante, c'est un trouble de réceptivité, c'est un trouble de récepteurs, des organes signes, des organes gènes, soit ils sont absents, soit ils sont détruits. Donc c'est la testostérone féminine.

L'individu, la patiente, a été considérée comme fille depuis la naissance, parce qu'il n'avait pas de pénis, parce qu'il n'avait pas de testicules, il avait un plus ou moins grand clitoris, il avait un pseudo-vagin, et avec le temps, il a développé des caractères sexuels secondaires féminins, et il a atteint une ambiguïté sexuelle, c'est comme une ambiguïté sexuelle. À l'âge adulte, il a développé des caractères sexuels secondaires, mais d'aspect féminin. Lorsqu'on fait le carotide, c'est un 46XY, c'est un membre qui n'a pas de testicules migraines, pour qu'il migre, il faut qu'il y ait des récepteurs aux androgènes, la migration du testicule de l'abdomen vers le scrotum, c'est sous l'effet de beaucoup de choses, entre autres les androgènes.

C'est pas des androgènes, même cette migration est légère. Alors voilà l'aspect du cas du testicule féminin, mais comme je l'ai déjà expliqué, l'aspect, c'est comme l'aspect féminin, c'est un petit peu plus simple, c'est un petit peu plus rapide, mais pas complètement, c'est l'aspect féminin. Lorsqu'on fait l'imagerie, on trouve que les testicules sont au niveau du pelvis, alors ces testicules-là, lorsqu'ils migrent, comme dans les extrémités testiculaires, il faut faire leur ablation, il n'y a pas de récepteurs, il n'y a rien à faire, qu'est-ce que les récepteurs ? On ne peut pas fabriquer des récepteurs pour toutes les cellules.

Pour éviter le cancer, on fait la résection de ces cellules-là et on donne un traitement hormonal subsidier. Voilà les testicules après la scission. On prépare les testicules après la résection du pelvis.

Le reste, c'est le type d'études qui ont été faites. Les études qui ont été faites en tant que filles, on ne va pas aller jusqu'à l'âge de 15-17 ans, on change tout. On maintient la même chose, on met juste les risques potentiels Le cancer du testicule qui n'est pas hormonal, extra-abdominal.

Donc, on a parlé des problèmes sexuels et hormonaux, les problèmes anatomiques, s'il y a douleur cyclique, il y a des diagnostics anatomiques, s'il n'y a pas de douleur cyclique, il y a la génocide, il y a la tuberculose, et il y a le testiculofémisme. Donc, logique, c'est pour simplifier les choses, c'est vraiment pour simplifier les choses. Maintenant on passe, on a dit qu'il y a les caractères sexuels secondaires qui sont normaux, maintenant on va parler des caractères sexuels secondaires qui sont virilisants, donc il y a beaucoup d'androgènes, il y a beaucoup d'androgènes virilisants.

Alors, on a dit qu'on n'utilise pas du sérénal, mais tu vas voir qu'il se créent des oestrogènes, il y en a beaucoup, et certains animaux de longue vie qui se créent des oestrogènes, comme l'hystérone, mais qui se créent également des androgènes. On va aller voir ça. Alors, c'est quoi le problème des caractères sexuels secondaires ? C'est un problème légitimisé qui fait que les récurseurs du cortisone ont un effet androgénique, on n'a pas de cortisone et on a des récurseurs qui passent dans le sang qui ont un effet virilisant, androgénique.

Ça donne une anémorrhée et ça donne des caractères sexuels secondaires en fonction de ce qui circule dans la circulation, ce qui circule dans la circulation sanguine. C'est beaucoup de remords. Lorsque vous avez un bloc enzymatique, les métabolites, avant l'accès à cette enzyme, elles sont en excès.

Notamment, l'hyperplasie, ce qui manque c'est le cortisone. On a une enzyme qui ne fait pas arriver le cholestérol jusqu'au cortisone. Les récurseurs du cortisone ont un effet androgénique qui donne une hyperplasie congénitale sur une âme avec des signes d'hyperandrogénie, une anémorrhée et tout ça.

Donc ça pour l'hyperplasie congénitale. Alors le traitement ça va être quoi? Le traitement d'une

hyperplasie congénitale. Ce qui manque c'est la cortisone.

Il faut supplémenter la cortisone et il faut donner des traitements anti-androgéniques. On donne des traitements, heureusement qu'il y a des médicaments qui agissent contre le traitement androgénique afin que la femme ait un aspect féminin et moins d'effets androgéniques, moins de problèmes androgéniques. Alors qu'est-ce qu'une tumeur qui sécrète également des enzymes androgènes? Caractère sexuel, donc anémorrhée avec caractère sexuel secondaire masculinisé.

Alors c'est une tumeur qui peut être soit au niveau du bordère, soit au niveau du surrénal. Ça c'est les deux sièges où on peut avoir en général des tumeurs qui sécrètent. Le troisième cas de figure, c'est le syndrome des ovaires polycystiques, dont on a parlé dans les appels aux maladies terribles.

Polycystic ovary syndrome ou PCOS, c'est la même chose qu'OPK. PCOS c'est en anglais, ovaire polycystique c'est en français. Alors cette ovaire polycystique, il y a des problèmes d'ovulation, qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'hormones d'histoires des progéniteurs, il y a une dystrophie ovarienne.

Quelque chose de moins. Donc dans le syndrome des ovaires polycystiques, normalement je vais en parler dans les anémorrhées secondaires. Ça c'est une cause qu'on peut trouver soit dans les anémorrhées polymères, caractère sexuel secondaire masculinisé, absence d'air électoral contre les ovaires polycystiques, soit on peut trouver dans les anémorrhées secondaires, comme dans le cas du virus, dans les anémorrhées secondaires.

La figure, c'est qu'il n'y a pas de caractère sexuel secondaire, donc c'est un sué qui est infantile. Alors du temps, il a toujours l'aspect où il n'est pas encore pubert, il n'a pas, c'est pas virilisé, il n'a pas de caractère sexuel secondaire, mais il n'y a rien, c'est un enfant. Alors on demande à la radiographie de l'âge osseux pour voir est-ce qu'il a terminé sa croissance zoonique.

S'il n'a pas terminé, s'il y a une anémorrhée du pouce, il est absent. Ça veut dire que ce 17 ans n'a pas encore terminé sa croissance et on a espoir. On se dit que c'est un retard pubertaire.

Réalisation c'est 16 ans, alors dans ce cas-là, l'occlusion du pouce ne l'a pas encore, donc il n'a pas encore terminé sa croissance et on a espoir. Si jamais il a l'occlusion du pouce, c'est qu'il a terminé sa croissance, il devait avoir un axe hypothalamo-hypophysé-ovaire qui ne fonctionnait, et qu'il ne fonctionne pas. Il faut chercher la cause, pourquoi.

Pourquoi il a terminé sa croissance, mais il n'arrive pas à sécréter des ennus sexuels. Donc c'est très probablement qu'il y a un problème au niveau des ovaires. Lorsque l'âge de 16 ans est absent, il s'agit d'un retard pubertaire.

Alors quelles sont les situations qu'on peut avoir à 17 ans et qu'il a un retard ? C'est les enfants

qui ont passé des maladies graves durant leur enfance. Ils n'ont pas encore acquis le capital pour donner des signaux au cerveau afin de commencer la puberté. Ce sont des maladies chroniques, comme l'hypopathie, la maladie cardiaque ou la carence nutritionnelle.

Donc on se dit qu'il est possible qu'il y ait une situation qui s'intègre à la croissance et à l'infantilisme. Dans ce cas-là, l'FSHL et l'ALH sont basses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les talons synéthrophiques ne sont pas encore matures, ils n'ont pas terminé sa croissance, et le système autopsie est absent, et c'est un des milieux qui a un retard pubertaire.

Alors si le système autopsie est présent, on se dit qu'il a terminé sa croissance mais il n'est pas encore pubert. On parle d'un puberisme. Il est un puber.

Le système est là, mais il n'a pas encore terminé, il n'a pas encore fait sa puberté, il ne va pas la faire parce qu'il a terminé sa croissance et il va faire sa puberté. Alors on demande le dosage de FSHLH pour voir si c'est dû à un problème périphérique ou à un problème central. Si on regarde le FSHLH, on peut voir s'il s'enlève ou s'élève, c'est d'origine périphérique.

S'il s'en bat ou s'il se dissocie, c'est d'origine centrale. Alors s'il s'enlève, ça veut dire que la cause est périphérique. La cause, c'est un problème qui n'est pas fonctionnel.

Soit c'est un turn-off, 45x, ou un turn-off vert. Soit c'est un problème qui n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas de follicule, non.

Les follicules ne sont pas normaux. Quand j'ai une option morphique qui s'associe, elle s'associe à une part variable de l'option d'un turn-off vert sans dysmorphine. Donc en termes d'identité psychologique, c'est presque la même chose, sauf qu'on est dans une dysmorphine.

Dans l'identité psychologique, c'est un turn-off vert, incomplet. On a une morphologie simple, sauf que l'identité psychologique ne fait pas son travail. Donc c'est une situation où on a une attribution de sa croissance, mais elle n'est pas encore puberte.

C'est même pubériste, il faut s'en souvenir. Donc c'est même pubériste de régime périphérique, c'est un vert qui ne fonctionne pas correctement. C'est un peu le cas de l'altération qu'on acquise, si c'est un enfant qui a reçu une chimiothérapie ou une radiothérapie en France.

À l'âge puberte, il aura terminé sa croissance, mais il a son sysamo du pouce, mais il faut savoir qu'il est très énervé parce que ses ovaires ont été détruites durant sa chimiothérapie ou sa radiothérapie. C'est pour cela qu'actuellement, dans le cadre de certains cancers qui nécessitent des traitements très agressifs, on prend les ovaires pour les congeler après la chimiothérapie. Et puis, un paramètre, c'est la congélation des ovaires.

C'est pour les sujets plus âgés, la congélation des ovaires. C'est une situation pérenne, on a détruit tout le capital funiculaire avec la chimiothérapie ou la radiothérapie. On en parle de la préservation de la fertilité après cancer, dans le cours sur le cancer.

Donc, si le message ouvert se lance, la préservation de l'énergie centrale, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, c'est central de la société, c'est-à-dire que ce qui est central, c'est tout ce qui est général, l'agent de la biodiversité, tout ce qui est général, l'agent de la biodiversité, c'est-à-dire que la question tout à fait différente de la question de ce qui est général. C'est la dissipation et la protection des animaux, le syndrome de morsicable, le syndrome de morsif, c'est la même chose, le syndrome de migration, Il y a un problème qui s'écrit dans le GNRH, c'est l'hépothalamus. Cet hépothalamus est très proche de l'hépothalamus et donc de ce syndrome-là, il y a un problème d'immigration.

Pour que l'hépothalamus agisse sur l'hépophyse, il faut qu'il déverse cet GNRH qui est une neuropéptide. C'est le neuronal qui s'écrit comme ça, c'est une neuropéptide à côté de l'hépophyse. Donc le système porte ce basculer, la bascularisation de l'hépophyse est très proche de l'hépothalamus.

Pour que l'hépophyse reçoive les incitations de l'hépophtalamus, il faut que l'hépophtalamus vienne à côté de sa bascularisation. Dans ce syndrome-là, il n'y a pas d'immigration. Donc il y a de la GNRH qui n'est pas déversée dans le système porte-hépophyseur, donc on va avoir une améliorée d'origine hépothalamique.

Donc on va avoir des conflits d'individus en partie. Nous ne sommes pas immigrés, nous ne vivons pas l'hépothalamus, nous vivons l'hépothalamus. Ça c'est parmi les causes centrales des symptômes d'hépophtalamus.

Donc on va avoir des symptômes d'hépophtalamus. S'ils sont énormés, les ovaires travaillent bien. Il y a probablement un problème soit anatomique soit général.

En fonction lorsqu'ils sont énormés, est-ce qu'il y a du douleur ou non. L'absence de douleur signifie qu'il y a un problème au niveau de l'endommagement et de l'immobilité. Je vous poursuis avec la question pour la prochaine fois avec les informations que vous avez.

Merci.